جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : سحر محمد علي احمد محمد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** مصر القديمه **العنوان :** ش حسن الانوار
رقم البطاقة : 28302150104566 **رقم التليفون :** 01001303585 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 15-02-1983 **المهنة :** حاصل علي بكالوريوس

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سحر محمد علي احمد محمد
National ID: 28302150104566

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

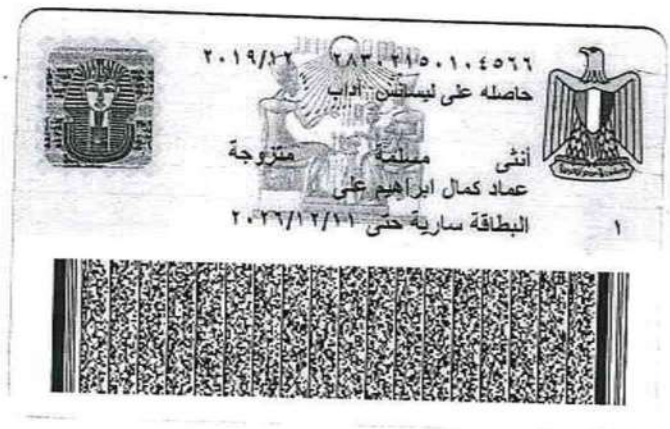
٠١٠٠١٣٠٣٥٨٥

٠١٠٠٥٨٣٤٤٠٤



١١٠٥٢

National ID · Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



National ID · Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: سحر محمد على احمد	
MR. : 11052	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 43-year-old individual who is pre-menopausal, with a positive family history and a comorbidity of rheumatoid disease. The clinical history is noted as NAD.

Core needle biopsy demonstrated invasive ductal carcinoma, grade III. Hormone-receptor testing showed estrogen receptor 8/8 and progesterone receptor 6/8, while HER2 was 0 and Ki-67 was 60. Imaging with contrast-enhanced spectral mammography (CESM) revealed a right breast lesion consisting of two pathological masses with enhancement in the retroareolar region measuring 3.8 × 4.2 × 3 cm, attached to a retracted nipple, and associated with two pathological axillary lymph nodes; the left breast was NAD. Metastatic workup with CT of the chest, abdomen, and pelvis was free except for a left hepatic focal lesion measuring 2.5 cm, which was subsequently excluded as metastatic disease on dynamic MRI, rendering the study free of metastases.

The referring team recommended neoadjuvant chemotherapy (NACT) with placement of a porta-cath, clipping of the two retroareolar masses, followed by central quadrantectomy and lymph node surgery according to response. The multidisciplinary team concurred and planned placement of a porta-cath and echocardiogram, clipping of the two retroareolar masses, NACT consisting of 4 cycles of AC plus 4 cycles of Taxotere, and then radiotherapy, central quadrantectomy, and lymph node surgery according to response.

تحريرا في ,

التاريخ :	23-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج :

يعتمد ,

Patient ID: 95266	Patient Name English: Sahar Mohamed Ali Ahmed
Age: 43y	2026/05/10 12:02:28 PM :Report Date

Women's Health Outreach Program
Bilateral full field Digital Mammography

Clinical summary: Right retroareolar lump, increasing in size through last 6 months.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views & High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- Retroareolar focal asymmetry with few microcalcific foci.
- **Ultrasound** demonstrated Palpable 6:00 para-areolar altered heterogeneous hypoechoic parenchyma. Internal vascularity detected by Color Doppler US. It measures about 4.5x2 cm.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- A single pathological axillary lymph node is detected at level 1. It measures about 1.7x0.8 cm with effaced hilum and 0.6 cm focal cortical thickening.

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Right breast (BIRADS 4): 6:00 para-areolar palpable focal asymmetry with underlying altered parenchyma. For histopathological correlation**
- **Left breast (BI-RADS 1): Normal study.**

Best regards,
Dr. Ghada Khaled, MSc

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

NHTMRI

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

قسم الباثولوجى

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: سحر محمد علي احمد	**Age:** 43years	**Sex:** female
Request type: ميادره	**Sub request type:**	
Hospital no:	**Pathology no.:**329-2026	
Department:صحه مرأه	**Date of result:**16/5/2026	
Referred by: د/غاده خالد	**Date of biopsy:**10/5/2026	
Nature of specimen: tru-cut biopsy	**I.D. Number:**28302150104566	

Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology : multiple gray white tissue cores up to 1cm long, totally submitted

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67.

Microscopic picture: Section examined revealed core of mammary tissue showing invasive ductal carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nest, sheets and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing marked anaplasia and mild tendency to from tubules with frequent mitotic figures. There is Carcinoma insitu component is seen of solid and comedo patterns of low and intermediate grade. No peritumor lymphovascular emboli or perineural infiltration seen in core tissue examined.

Immunohistochemical Result;

ER: Strong Positive nuclear staining in 80% of tumor cells (Allred Score 8/8).
PR: Moderate nuclear staining of 60% of tumor cells (Allred Score 6/8).
Her2: Weak incomplete membranous staining of <10% of tumor cells (Score 0). Her2 Extra low
Ki67: Positive nuclear staining of 60% of tumor cell

Diagnosis: Right breast mass, Tru-Cut Biopsy:

Invasive ductal Carcinoma, (NST) Grade III.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

Nermine Nabil, M.D

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]